

Historia electrónica, respaldo, restauración y contingencia

Procedimiento | Alcance base: fisioterapia | Estado: propuesta para adopción

1. Objetivo y resultado esperado

Evitar pérdida, exposición y registro sin autorización cuando falla el sistema o cambia proveedor.

2. Alcance y condiciones de uso

Sistemas existentes; la plantilla no certifica el software ni diseña su seguridad completa. Historia en papel exige controles equivalentes de reserva y conservación.

3. Responsabilidades por rol

Rol	Responsabilidad
Autor de la atención	Registrar de manera oportuna, íntegra y autenticada.
Custodio	Controlar acceso, conservación, entrega y recuperación.
Apoyo administrativo	Acceder solo a datos necesarios según permiso.

4. Recursos y preparación

Mantener documento vigente, responsables reales, recursos de la actividad y soportes del emisor o fabricante pertinentes. Antes de ejecutar comprobar disponibilidad y seguridad; si falta un recurso crítico, controlar el riesgo y registrar suspensión o alternativa.

Secuencia operativa y decisiones

El orden se adapta al episodio sin omitir los controles de seguridad. Las técnicas y parámetros concretos se definen por competencia, evidencia y fabricante; no se completan con valores de ejemplo.

1. Inventariar sistema, proveedor, permisos, almacenamiento y copias

Inventariar sistema, proveedor, permisos, almacenamiento y copias. Usar cuentas individuales, contraseñas y acceso mínimo; evitar usuarios compartidos o exportaciones sin control.

2. Verificar integridad, fecha hora, autoría, historial de cambios y posibilidad de recuperar

Verificar integridad, fecha hora, autoría, historial de cambios y posibilidad de recuperar el expediente. Solicitar soportes al proveedor sin confundir publicidad con prueba técnica.

3. Programar respaldo según riesgo y volumen y mantener copia protegida separada

Programar respaldo según riesgo y volumen y mantener copia protegida separada. Registrar ejecución, alcance y resultado y verificar que se incluyan anexos y consentimientos.

4. Probar restauración en ambiente controlado sin exponer datos del paciente

Probar restauración en ambiente controlado sin exponer datos del paciente. Registrar tiempo, integridad y capacidad de abrir los registros; una copia sin prueba no garantiza recuperación.

5. Ante caída, usar historia física de contingencia con fecha, hora y autor auténtico y atenc

Ante caída, usar historia física de contingencia con fecha, hora y autor auténtico y atención segura. Al volver el sistema incorporar la información conservando original, fecha real y trazabilidad sin duplicar sesión.

6. Ante migración o cierre verificar exportación íntegra, custodia y acceso, borrar copias no

Ante migración o cierre verificar exportación íntegra, custodia y acceso, borrar copias no necesarias de forma segura y conservar las obligatorias. Gestionar incidentes con aislamiento y análisis.

Control, frecuencia y corrección

5. Verificación de la ejecución

Respaldos programados y comprobados.

Restauración local periódica según plan.

Contingencia no elimina autenticación.

Momento	Comprobación y conducta
Antes	Verificar alcance, recurso y condición de uso descritos. Resolver discrepancias antes de comenzar; documentar aplazamiento cuando no es seguro.
Durante	Seguir los pasos de este documento y registrar modificaciones, novedades y actuaciones reales. Detener ante los criterios de riesgo del proceso.
Después	Comprobar resultado, integridad, limpieza o continuidad según proceso. Vincular registro y autor, sin dar por cumplida una tarea no observada.
Ante hallazgo	Contener el riesgo, describir causa, asignar acción y comprobar eficacia. Mantener abierto el pendiente mientras no exista evidencia de cierre.

6. Registro, conservación y seguimiento

Utilizar la ficha o formato asociado y conservar fecha, episodio, ejecutor y soporte. Los registros clínicos se incorporan a la historia reservada; documentos laborales y administrativos tienen acceso según su finalidad. Reproducir páginas de registro cuando se necesita espacio, sin condensar la información clínica ni registrar valores supuestos.

7. Aplicación normativa específica

11.1.6 y 11.3.1.27-28: historia y registros; Resoluciones 1995/1999, 839/2017, Ley 1581/2012 y consentimiento conforme a Ley 528/1999 y reglas particulares.

8. Adopción y revisión

Completar responsables y condiciones de sede, leer referencias y manuales íntegros, validar el proceso y socializarlo. Registrar versión adoptada y autenticación; revisar ante cambio de norma, producto, equipo, técnica o hallazgo y en el ciclo local anual. Frecuencias y metas locales de esta edición no se presentan como exigencias legales universales.

Ficha de aplicación y referencias

Registro vacío para reproducir. Completar solo con hechos reales; identificar el documento o expediente al que pertenece. No incluye nombre, logo ni firmas preincorporadas.

Sistema y proveedor	
Cuenta y rol	
Fecha respaldo	
Alcance y ubicación protegida	
Resultado	
Prueba de restauración	
Integridad y tiempo	
Caída y contingencia	
Incorporación trazable	
Custodia en migración	

Fuentes y límites

Habilitación

Resolución 3100 de 2019 y modificaciones vigentes; manual, criterios generales 11.1 y servicio de terapias 11.3.1. Resolución 2080 de 2026, artículo 1: revocatoria integral de 1732 de 2026; no se utiliza su manual como exigencia vigente.

https://normograma.supersalud.gov.co/compilacion/docs/resolucion_minsaludps_3100_2019.htm

Historia clínica

Resolución 1995 de 1999, artículos 3-5 y 11-14: registro, autoría, anexos, custodia y acceso. Resolución 839 de 2017, artículo 3: retención general mínima de 15 años y reglas especiales; el archivo no se elimina automáticamente al vencer un plazo.

<https://minsalud.gov.co/ihce/Paginas/Normatividad.aspx>

Datos sensibles

Ley 1581 de 2012, artículos 4-6, 8-12 y 17-18; Decreto 1074 de 2015, reglas de tratamiento. Información de salud y finalidades opcionales requieren análisis de base jurídica, autorización cuando exigible y seguridad.

<https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=49981>

Aprobó

Eliana Milena Pardo Ríos

TP 60576